

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SKRINING DAN ERADIKASI (METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS)		
	No.Dokumen 337.14/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 1 / 3
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Merupakan prosedur untuk melakukan skrining dan eradikasi MRSA. MRSA adalah bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> yang resisten terhadap antibiotic golongan beta lactam (<i>oxacillin</i> , <i>penicillin</i> dan derivatnya, <i>cephalosporins</i> , <i>dancarbapenem</i>). MRSA menimbulkan infeksi sistemik yang mengancam jiwa seperti sepsis, infeksi luka operasi, dan <i>pneumonia</i> . Terapi anibiotika untuk infeksi MRSA sangat terbatas.		
Tujuan	Untuk menurunkan angka karier dan akuisisi MRSA pada pasien dan petugas kesehatan sehingga angka infeksi MRSA dapat dikendalikan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
Prosedur	Persiapan alat dan bahan: 1. Amies transport medium (sudah termasuk lidi dacron steril). 2. Mupirocin salep hidung. 3. Cotrimoxazole 960 mg. 4. C Chlorhexidin gluconat 1,5% untuk rawat luka (hanya bila kultur swab luka menunjukkan positif MRSA). 5. Partisi untuk <i>cohorting</i> atau ruang isolasi (bila ada). Persiapan petugas : Perhatikan tehnik aseptik dan ketepatan dalam mengambil sampel swab hidung, swab tenggorok, dan swab luka terbuka (bila ada). Pelaksanaan prosedur: Perawat: 1. Lakukan kategorisasi pasien berdasarkan Panduan Skrining dan Eradikasi MRSA untuk menentukan pasien perlu dilakukan skrining MRSA atau tidak. 2. Informasikan kepada dokter yang merawat apabila pasien masuk dalam salah satu kategori untuks krining MRSA. 3. Lakukan skrining MRSA dengan melakukan pengambilan sampel kultur swab hidung, swab tenggorok, dan swab lukater buka (bila ada) terhadap pasien yang masuk dalam salah satu kategori tersebut (lihat SPO Pengambilan Sampel Skrining MRSA). 4. Kirimkan sampel skrining MRSA (point 2) dengan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SKRINING DAN ERADIKASI (METHICILLIN-RESISTANT <i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i>)		
	No.Dokumen 337.14/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 2 / 3
lembar pengantar kultur yang bertuliskan “SKRINING MRSA” di pojok kanan atas disertai tanda-tangan dokter yang merawat ke Instalasi Mikrobiologi Klinik untuk dilakukan kultur dan identifikasi MRSA. Letakan tali elastis bagian atas ke belakang kepala bagian atas. Instalasi Mikrobiologi Klinik : 1. Lakukan kultur swab hidung, swab tenggorok, dan luka terbuka bila ada (skrining MRSA) pada medium Brilliance MRSA dalam waktu 24 jam. 2. hlorhexidin gluconat 4% untuk mandi 3. Identifikasi koloni yang tumbuh pada medium Brilliance MRSA sebagai koloni khas MRSA atau bukan MRSA. Bandingkan dengan bakteri kontrol (ATCC) 4. Segera kirimkan hasilnya kepada dokter yang mengirim sampel kultur tersebut. Bila hasil kultur skrining MRSA menunjukkan positif MRSA maka: Perawat : 1. Lakukan cohorting (memisahkan) pasien tersebut dari pasien negatif MRSA menggunakan partisi/ruang isolasi. 2. Lakukan koordinasi dengan dokter yang merawat dan petugas farmasi untuk melakukan tindakan eradikasi terhadap pasien dengan positif MRSA. 3. Laporkan kasus positif MRSA kepada IPCLN ruangan. Dokter, Perawat, dan Petugas Farmasi: Lakukan tindakan eradikasi terhadap pasien positif MRSA meliputi: - Pasien mandi dengan chlorhexidin gluconat 4% dua kali sehari selama 7 hari. - Pemberian mupirocin salep hidung 2% dua kali sehari selama 7 hari (bila kultur swab hidung menunjukkan positif MRSA). - Pemberian cotrimoxazole 2x960 mg selama 7 hari (bila kultur swab tenggorok menunjukkan positif MRSA). - Bila terdapat luka dengan hasil kultur luka menunjukkan positif - MRSA: irigasi luka dengan kombinasi NS steril dan chlorhexidin gluconat 1,5% setiap 3 hari sebanyak 7 kali. Bila terdapat kemajuan hasil terapi maka irigasi dilanjutkan sampai 14 kali. IPCLN : Dokumentasikan kasus karier maupun infeksi MRSA untuk			

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SKRINING DAN ERADIKASI (METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS)		
	No.Dokumen 337.14/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 3 / 3
	kemudian dilaporkan kepada Tim PPI dan Komite PPI. Komite PPI: 1. Lakukan koordinasi dengan Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) untuk melakukan <i>cleaning</i> dan <i>disinfecting</i> ruangan dimana pasien positif MRSA dirawat. 2. Dokumentasi laporan dari IPCLN, analisa laporan tersebut dan susun rencana tindak lanjut dengan pimpinan rumah sakit. 3. Kirim laporan kejadian ke bidang evaluasi dan pelaporan. Pasca tindakan eradikasi MRSA Dokter dan Perawat 1. Kirimkan ulang swab hidung, swab tenggorok, dan luka terbuka (bila ada) untuk mengetahui status karier MRSA ke Instalasi Mikrobiologi Klinik. 2. Bila hasil kultur ulang menunjukkan negatif MRSA maka terapi eradikasi dinyatakan selesai. 3. Bila hasil kultur ulang masih menunjukkan positif MRSA maka terapi eradikasi diulang kembali sampai negatif. Instalasi Mikrobiologi Klinik : Bila hasil kultur ulang masih menunjukkan positif MRSA maka uji kepekaan antibiotika dilakukan terhadap isolat MRSA tersebut.		
Unit Terkait	1. Instalasi IGD 2. Instalasi IRNA 3. Instalasi IRJA		